

TRABAJO PRÁCTICO – UNIDAD 2

Propuesta, alcance y gestión de interesados

Materia: Gestión de Desarrollos de Software

Unidad 2: Propuesta, alcance y gestión de un proyecto

Alumno: Nicolás Viruel

Caso de estudio: HealthConnect

La clínica privada **HealthConnect** quiere una plataforma web para que los pacientes soliciten, reprogramen y cancelen turnos médicos en línea. Hoy todo se hace por teléfono, con demoras y turnos perdidos. La dirección pide la solución en **4 meses**, con **presupuesto acotado**, cumpliendo **normativa de privacidad de datos médicos** y permitiendo que el **personal administrativo** lo use sin dificultades técnicas.

Actividad 1: Gestión del Alcance

1. Definición de Inclusiones y Exclusiones

a) Inclusiones (3)

1. **Portal web de autogestión de turnos para pacientes:** registro/login, búsqueda de disponibilidad por especialidad/médico, reserva, reprogramación y cancelación de turnos con confirmación por pantalla y/o correo.
2. **Panel administrativo para recepción:** visualización de agenda diaria/semanal, alta de profesionales y horarios, y gestión manual de turnos cuando un paciente llama o concurre presencialmente.
3. **Cumplimiento básico de privacidad de datos médicos:** autenticación segura, control de acceso por rol (paciente / administrativo / médico), registro de acciones sensibles y almacenamiento de datos clínicos mínimos necesarios para la reserva (sin historial clínico completo en esta etapa).

b) Exclusiones (3)

1. **Historia clínica electrónica (HCE) completa:** no se desarrollará carga de diagnósticos, estudios, recetas digitales ni evolución clínica; solo lo necesario para gestionar la cita.
2. **App móvil nativa (iOS/Android):** la solución será **web responsive**; no se incluyen publicaciones en stores ni desarrollo mobile nativo.
3. **Integración con obras sociales / facturación / pagos online:** no se implementará liquidación de prestaciones, autorizaciones de OS ni cobro de consultas dentro del sistema.

2. Prevención del Scope Creep

1. **Documento de alcance firmado + proceso de Change Request:** antes de iniciar el desarrollo, la dirección de la clínica valida por escrito inclusiones, exclusiones y entregables por sprint. Cualquier pedido nuevo (ej. "sumemos videoconsulta" o "que mande WhatsApp") entra por un formulario de cambio con impacto en **tiempo, costo y calidad**, y solo se aprueba si hay ajuste formal de plazo/presupuesto.
 2. **Backlog priorizado con criterio MoSCoW y demo quincenal:** en cada iteración se muestra solo lo acordado como *Must*. Las ideas "interesantes pero no pactadas" van a una lista de *Won't/Could* para una fase futura, evitando que el cliente incorpore funcionalidades durante la demo sin pasar por gestión de cambios.
-

Actividad 2: Gestión de Interesados (Stakeholders)

1. Matriz de Clasificación (4 stakeholders)

Stakeholder	Tipo	Rol / interés principal	Influencia	Expectativa clave
Project Manager / Líder de proyecto	Interno	Coordina plan, alcance, riesgos y comunicación	Alta	Entregar a tiempo, dentro de presupuesto y sin desvíos de alcance
Equipo de desarrollo (dev + QA)	Interno	Diseña, implementa y prueba la plataforma	Media-Alta	Requerimientos claros, prioridades estables y acceso a ambiente de prueba
Dirección de HealthConnect (Gerencia)	Externo	Sponsor; define plazos, presupuesto y prioridades de negocio	Muy alta	Reducir llamadas telefónicas, mejorar experiencia del paciente en 4 meses
Personal administrativo / recepción	Externo	Usuario operativo diario del panel de turnos	Media	Sistema simple, rápido de aprender, que no duplique trabajo ni genere errores en la agenda

(También son stakeholders externos relevantes los **pacientes** y un eventual **responsable legal/auditoría de datos**; para la consigna se detallan los cuatro anteriores.)

2. Estrategia de comunicación – Dirección de HealthConnect (stakeholder externo)

Objetivo: alinear expectativas sobre plazo (4 meses), presupuesto acotado y alcance MVP, y mantener visibilidad del avance sin saturar reuniones.

Estrategia concreta:

- **Kick-off formal (semana 1):** presentación del documento de alcance, cronograma por hitos y riesgos iniciales; acuerdo explícito de exclusiones (sin HCE, sin app nativa, sin facturación).
- **Reporte ejecutivo quincenal (1 página):** avance % por hito, turnos funcionales demo, riesgos abiertos y decisiones pendientes; enviado por mail + reunión de 30 minutos.
- **Canal único de priorización:** la gerencia no pide cambios por WhatsApp al dev; todo pasa por el PM, que evalúa impacto y responde en 48 h con alternativas (aceptar cambio con extensión, posponer a fase 2, o rechazar por restricción de presupuesto/tiempo).
- **Demo al cierre de cada sprint:** validación visual de funcionalidades terminadas; lo no mostrado no se considera entregado.

Actividad 3: Riesgos, Supuestos, Restricciones y Criterios de Aceptación

1. Supuestos y Restricciones

a) Supuestos (2)

1. **El personal administrativo tiene acceso a PC con navegador actualizado e internet estable** en recepción para operar el panel web sin necesidad de capacitación intensiva en informática.
2. **La clínica dispondrá de información base ordenada** (listado de médicos, especialidades y grilla horaria) antes o durante las primeras semanas del proyecto, para no bloquear el desarrollo del módulo de reservas.

b) Restricciones (2)

1. **Tiempo:** la solución debe estar lista en un **plazo máximo de 4 meses** desde el inicio del proyecto (restricción de cronograma).
2. **Legal / normativa:** el sistema debe cumplir **estrictamente** las regulaciones locales de **privacidad de datos médicos** (restricción legal/compliance), lo que condiciona diseño de seguridad, permisos y tratamiento de datos personales sensibles.

(También aparece explícita la restricción de **presupuesto acotado** y la de **usabilidad para personal no técnico**.)

2. Criterios de aceptación – Reserva de Turnos (formato BDD)

Criterio 1 – Reserva exitosa

- **Dado que** un paciente autenticado consulta la disponibilidad de un médico con turnos libres en la especialidad elegida
- **Cuando** selecciona un horario disponible y confirma la reserva
- **Entonces** el sistema registra el turno a su nombre, lo descuenta de la agenda y muestra confirmación en pantalla (y/o envía notificación al correo registrado)

Criterio 2 – Prevención de doble reserva

- **Dado que** un horario ya fue reservado por otro paciente
- **Cuando** un segundo paciente intenta reservar el mismo horario con el mismo médico
- **Entonces** el sistema no permite confirmar la operación e informa que el turno ya no está disponible, ofreciendo alternativas de horarios libres

3. Uso reflexivo de la Inteligencia Artificial

a) ¿Qué aportes específicos puede generar la IA en esta etapa inicial?

- **Borrador del documento de visión** y resumen ejecutivo del problema (dolor actual telefónico, objetivos de negocio).
- **Listado preliminar de stakeholders**, riesgos y supuestos a partir del enunciado del caso, acelerando el trabajo del PM.
- **Propuestas de criterios de aceptación en formato BDD** para funcionalidades como reserva, cancelación y reprogramación, que luego el equipo adapta al dominio real.
- **Identificación de requisitos no funcionales** típicos (seguridad, privacidad, usabilidad) en proyectos de salud.

b) ¿Por qué no debe entregarse directamente al cliente sin validación del equipo?

Porque la IA **no conoce el contexto real** de HealthConnect: puede inventar integraciones, subestimar restricciones legales argentinas, proponer un alcance irreal para 4 meses o usar lenguaje demasiado genérico. También puede **omitir exclusiones críticas** y generar ambigüedades que después derivan en scope creep.

El equipo de desarrollo y el PM deben **validar factibilidad técnica, costos, plazos y compliance** con datos reales de la clínica antes de presentar cualquier documento al cliente. La IA es un asistente para el borrador; la **responsabilidad profesional** del contenido final es del equipo humano.